

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

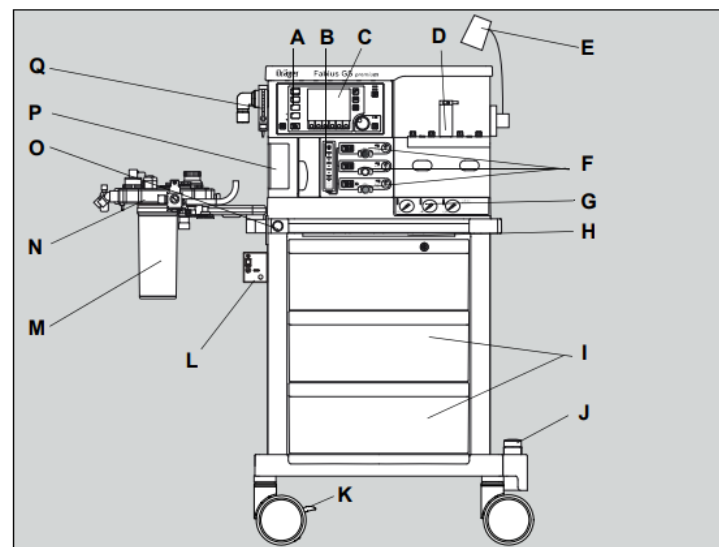


MAQUINA DE ANESTESIA

MARCA: DRÄGER
MODELO: FABIUS GS

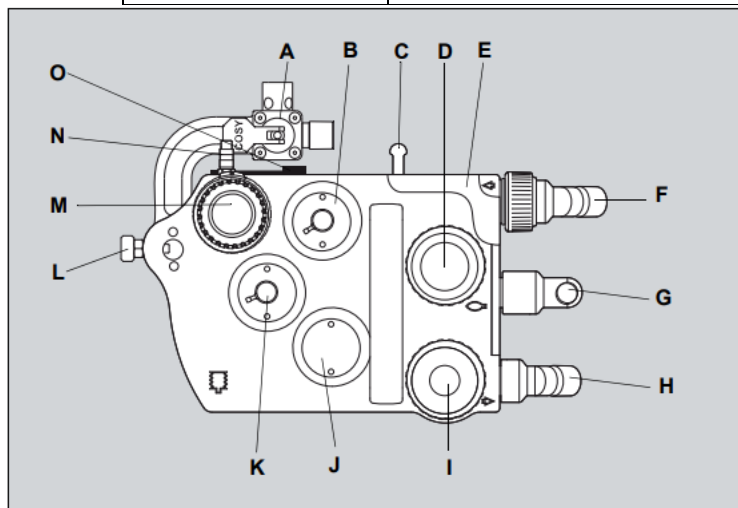
Recomendaciones antes de usar

- Revise por daños visibles, compruebe la estabilidad del equipo y la condición de las mangueras de suministro de gas.
- Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro eléctrico. El LED de la parte delantera del dispositivo se debe iluminar verde.
- Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro de gas.
- Verifique el suministro adecuado del cilindro de respaldo.
- Verifique la correcta conexión y funcionamiento de los vaporizadores.
- Compruebe la integridad del circuito paciente.

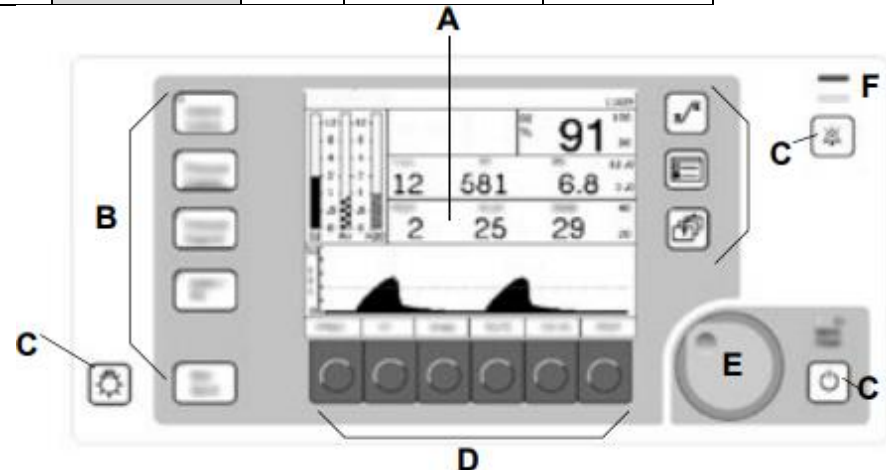


No.	Nombre	No.	Nombre
A	Panel de control de ventilador	J	Freno central
B	Flujómetro total	K	Freno de rueda pivotante
C	Pantalla	L	Fuente de alimentación para la calefacción del sistema respiratorio COSY
D	Soporte del vaporizador	M	Absorbedor de CO2
E	Iluminación del equipo	N	Sistema respiratorio compacto
F	Suministro de gas fresco	O	Lavado de O2
G	Manómetro para botellas de gas	P	Ventilador
H	Bandeja escritorio	Q	Suministro de O2 adicional para insuflación de O2
I	Cajones		

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO			
		VERSIÓN		PÁGINA	DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO



No.	Nombre	No.	Nombre
A	Salida de gas fresco externa	I	Válvula inspiratoria
B	Conexión para válvula PEEP/Pmax	J	Válvula de desacoplamiento del gas fresco
C	Soporte de la bolsa reservorio	K	Conexión para válvula de bypass APL
D	Válvula espiratoria	L	Soporte con pasador de bloqueo
E	Protector del sensor de flujo o protección COSY	M	Válvula APL con selección de ventilación manual y respiración espontánea
F	Puerto espiratorio	N	Conexión para la línea de muestreo
G	Conexión para bolsa reservorio	O	Soporte para línea de muestreo
H	Puerto inspiratorio		



No.	Nombre	No.	Nombre
A	Pantalla	D	Teclas programables o de funciones variables
B	Tecla para seleccionar los modos de ventilación (empezando desde la parte superior): • Volumen controlado • Presión controlada • Soporte presión • SIMV/PS • ManSpont	E	Mando giratorio para seleccionar y confirmar los ajustes
C	Tecla para más funciones	F	Indicador LED

Aceptar paciente nuevo:

1. Pulse la tecla  y confirme.
2. Pulse la tecla “Restaur. Valores predeter”
3. Compruebe todos los componentes.
4. Si es necesario, realice la prueba de fugas.
5. Ajuste el modo de ventilación y continúe.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

Modos de operación:

Al iniciar el equipo, este se pondrá en modo **Espera**, en este modo se aparecerán dos instrucciones en pantalla: Un bloque superior donde indica que botón pulsar para iniciar la operación y un bloque inferior donde se muestra la última comprobación del sistema.

El flujo de gas fresco se puede modificar antes de seleccionar el modo de ventilación.

Ajuste el flujo de gas fresco en la estación de anestesia.

Modo ventilación ManSpont (Manual/Espontanea):

Espontanea:

- Gire la cabeza de la válvula APL en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición final. La etiqueta **Spont** y los dos puntos quedan alineados verticalmente entre sí.
- Ajuste un flujo de gas fresco adecuado.
- Pulse la tecla ManSpont.
- Confirme el nuevo modo.

Manual:

- Ajuste la cabeza de la válvula APL a la presión máxima deseada en las vías aéreas.
- Pulse la tecla ManSpont.
- Confirme el nuevo modo.
- Para rellenar la bolsa reservorio, pulse la tecla O₂+
- Ajuste un flujo de gas fresco adecuado.

- Inicie la ventilación manual con la bolsa reservorio. La presión está limitada al valor ajustado en la válvula APL.

Modo Volumen Controlado:

- Pulse la tecla Volumen control.
- Configure los ajustes de ventilación en las teclas programables.
- Confirme el nuevo modo.

Modo Presión Controlada:

- Pulse la tecla Pressure Control.
- Configure los ajustes de ventilación en las teclas programables.
- Configure el nuevo modo.

Modo Soporte presión:

- Pulse la tecla Pressure support.
- Configure los ajustes de ventilación en las teclas programables.
- Confirme el nuevo modo.

Modo SIMV/PS

- Pulse la tecla SIMV/PS.
- Configure los ajustes de ventilación en las teclas programables. Para ajustar parámetros adicionales (Trigger, Flujoln, TINSP, TIP:TI) pulse la tecla **“mas”**.
- Confirme el nuevo método.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES		AÑO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Use agentes limpiadores recomendados por la institución

Use una solución de detergente suave y agua tibia para eliminar la mugre resistente.

Asegúrese que todos los residuos de agentes limpiadores han sido removidos del equipo.

Las mangueras del sistema de respiración y otros componentes deben esterilizarse según los métodos recomendados por el fabricante.

No limpie ningún componente en máquina de lavado automático.

Realice una limpieza exterior del equipo acorde al procedimiento interno del hospital. Retire toda la suciedad visible y seque el dispositivo si es necesario.

RECOMENDACIONES:

- Apague el equipo.
- Desconecte el cable de poder.

ADVERTENCIAS:

- No use ningún solvente fuerte o material abrasivo.
- No use materiales abrasivos.
- Evite mojar los conectores.
- No permita que el líquido se infiltre en áreas cerradas
- No use agentes abrasivos durante la limpieza.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

Falla	Posible causa	Solución
El equipo no enciende	Desconexión del fluido eléctrico.	Revise que la conexión al tomacorriente este correcta.
	Daño en el cable de poder o en el circuito interno del equipo.	Cambie el equipo si es posible y reporte el fallo.
	El fusible de la batería no esta conectado al dispositivo y el cable de poder no está conectado.	Retire el embalaje del fusible de la batería, retire el portafusibles, introduzca el fisible y enrósquelo con seguridad.
Fuga en el sistema	Canister mal bloqueado	Asegúrese de que el Canister se encuentre correctamente bloqueado en la posición “completamente cerrado”
	Circuito paciente mal posicionado.	Revise las conexiones del paciente y el equipo y haga las correcciones pertinentes. Si el error persiste, reporte.
	Elementos (Absorbedor de CO2, válvula APL, Bolsa reservorio, soporte de bolsa reservorio, trampa de agua)	Revise las conexiones de los elementos y ajústelas de ser necesario.
Reducción en la absorción de CO2	Canister mal bloqueado	Asegúrese de que el Canister se encuentre correctamente bloqueado en la posición “completamente cerrado”
Fallo del ventilador	El ventilador no vuelve a su estado inicial después de un mal funcionamiento.	1. Cambie al modo de ventilación Man/Spont. 2. Sitúe la válvula deseada en la posición Man. 3. Sitúe la válvula APL a la presión deseada. 4. Llene la bolsa reservorio si es necesario. 5. Ventile manualmente al paciente.
	El modo de respiración espontanea no se puede activar.	
Fallo del sensor de O2	El sensor de O2 no está conectado	Compruebe el sensor de O2, conéctelo correctamente y calíbrelo de nuevo
	El periodo de uso máximo del sensor de O2 ha finalizado	Sustituya el sensor de O2. Expóngalo al aire ambiente por 15 minutos antes de la calibración.